

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO
Kết luận cuộc họp tại Bệnh viện Từ Dũ cơ Sở 2
Ngày 19 tháng 5 năm 2026

Ngày 19/5/2026, BS CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện đã chủ trì buổi họp với Ban Điều hành, các khoa của Bệnh viện Từ Dũ cơ Sở 2.

Sau khi các khoa, phòng báo cáo tiến độ thực hiện và trao đổi, thảo luận với đại diện các khoa, Ban Điều hành, BS CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện có kết luận, chỉ đạo thực hiện các công tác sau trước ngày 26/5/2026:

1. Đối với công tác Hành chính quản trị:

a) Công tác ngoại cảnh và môi trường làm việc

- Khu vực X-quang: Phòng Hành chính Quản trị (HCQT): Khắc phục khóa cửa nhà vệ sinh và thực hiện che chắn các khu vực không hoạt động.

- Khu vực nhà ăn nhân viên:

+ HCQT: Phát quang cây cối xung quanh; sắp xếp khu vực mặt tiền, loại bỏ các vật dụng không cần thiết (xe đạp, chai lọ); di dời trụ điện 3 pha về phía sau khu nhà.

+ Điều dưỡng (ĐD) phối hợp HCQT: Trang bị thêm tủ lạnh; phân loại thực phẩm (đồ sơ chế và đồ đã chế biến) để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; dán thông báo và kiểm soát định kỳ 5S trong tủ lạnh nhằm loại bỏ thực phẩm quá hạn/không sử dụng.

+ ĐD phối hợp HCQT: Quy hoạch vị trí đặt cây nước lọc cho nhân viên.

+ HCQT: Tăng cường giám sát việc đỗ xe đúng quy định tại khu vực nhà nhân viên.

- Khu vực nhà đại thể:

+ HCQT: Kiểm soát vệ sinh và thực hiện 5S định kỳ bên trong khu vực; xử lý rác thải, vật dụng không sử dụng và thức ăn thừa quanh bồn cây, khuôn viên nhà đại thể.

b) Công tác quản lý trang thiết bị

- HCQT: Rà soát, lập danh sách các phòng khám chưa trang bị máy lạnh.

- HCQT: Điều chuyển máy lạnh từ CS1 sang CS2, hoàn thành trước ngày 22/5/2026.

2. Đối với công tác chuyên môn:

a) Công tác kiểm tra, giám sát:

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp (KHTH) rà soát và chấm dứt việc in trả kết quả X-quang; do hệ thống đã được liên thông PACS, việc in kết quả là không cần thiết.

- Phòng KHTH giám sát và yêu cầu báo cáo chi tiết các ca tai nạn, bao gồm phân loại, phân tích nguyên nhân và đặc điểm tổn thương.

- Phòng KHTH phối hợp BS. Duyệt theo dõi, giám sát các ca phẫu thuật bụng thành bụng có biến chứng nhiễm trùng.

- Phòng KHTH phối hợp Bác sĩ Trưởng khoa rà soát, đánh giá mức độ tuân thủ chuyên môn của các bác sĩ. Các trường hợp không tuân thủ phải thực hiện giải trình với Phòng KHTH.

- Phòng KHTH tổ chức đào tạo cho các bác sĩ mới; các bác sĩ phải được kiểm tra, đánh giá về nguyên tắc khám bệnh và kỹ năng sử dụng hệ thống HIS trước khi đảm nhận công việc.

- Phòng KHTH phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ (TCCB) xây dựng Bộ chỉ tiêu KPI đánh giá hoạt động của bác sĩ dựa trên các tiêu chí: thái độ, tinh thần hợp tác và tuân thủ, năng lực chuyên môn, và chất lượng khám toàn diện.

- Phòng KHTH phối hợp ĐD rà soát lại quy trình tiêm ngừa. Đối với các sự cố hoặc phản ánh của bệnh nhân liên quan đến tiêm ngừa, Phòng KHTH tiến hành rút kinh nghiệm chuyên môn; biên bản họp phải ghi rõ phân tích nguyên nhân gốc rễ và giải pháp khắc phục để không tái diễn, đồng thời liên hệ phản hồi kết quả xử lý đến bệnh nhân.

b) Công tác khám và điều trị:

- Xét nghiệm:

- + Phòng KHTH rà soát giấy hẹn trả kết quả, đảm bảo thời gian trả kết quả được hiển thị chính xác trên phiếu hẹn của bệnh nhân.

- Tất cả các phiếu in từ hệ thống HIS (chỉ định cận lâm sàng, toa thuốc, phiếu khám,...) phải đảm bảo bảo mật thông tin bệnh nhân theo đúng tiêu chuẩn đang thực hiện tại Cơ sở 1.

- Nội soi tiêu hóa: Tăng cường công tác tư vấn cho bệnh nhân có chỉ định nội soi tiêu hóa có gây mê.

- Công tác khám toàn diện: Phòng KHTH thực hiện phân tích và báo cáo hằng ngày về số lượng lượt khám sức khỏe, đồng thời báo cáo rõ nguyên nhân các trường hợp không thực hiện được khám sức khỏe toàn diện.

- Ca ung thư vú: Phòng KHTH phối hợp BS. Phượng tiến hành hội chẩn chi tiết ca ung thư vú; báo cáo kết quả đến BS. Ngọc Hải chậm nhất ngày 20/5/2026.

- Phòng KHTH xây dựng và tích hợp chương trình tầm soát ung thư vào quy trình khám bệnh thường quy.

- Phòng KHTH rà soát lại cách gọi tên các chương trình khám; không sử dụng từ “gói”, thay bằng từ “bộ”.

- Phòng KHTH triển khai chương trình “sổ giun định kỳ” nhằm tầm soát bệnh ký sinh trùng trong cộng đồng.

3. Đối với công tác quản lý khác:

a) Công tác quản lý chung:

- Phòng TCCB triển khai kế hoạch luân chuyển công tác tại cơ sở 2: nhân sự phụ trách chuyên môn thực hiện luân chuyển trong vòng 3 tháng; nhân sự phụ trách quản lý và điều hành thực hiện trong vòng 6 tháng. Ưu tiên hình thức xung phong.

- Phòng TCCB triển khai cử nhân sự tham dự tập huấn sử dụng máy CT tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

- Phòng KHTH chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết 6 tháng hoạt động của cơ sở 2.

- Phòng KHTH phối hợp Ban Điều hành xây dựng kế hoạch thu hút bệnh nhân và nâng cao tỷ lệ bệnh nhân quay lại tái khám.

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) nhắc lần 2 việc báo cáo phương án tăng hiệu suất xử lý đồ vải tại cơ sở 2; Phòng TCCB cử nhân sự học tập cách thức triển khai tại Bệnh viện Tâm Anh và Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

- Phòng TCCB phối hợp Phòng KHTH xây dựng và triển khai phương án tăng số lượng lượt khám sức khỏe và khám đoàn.

- Phòng KHTH phối hợp Bộ phận Điều hành xây dựng phương án tổ chức khám đoàn tại khu vực riêng biệt, tách biệt khỏi luồng bệnh nhân khám bệnh thông thường.

- Phòng ĐD rà soát lại công tác điều phối tại khu vực đo sinh hiệu; khu vực này chỉ thực hiện chức năng đo và ghi nhận chỉ số sinh hiệu. Bác sĩ tại mỗi phòng khám chịu trách nhiệm nhập chỉ số sinh hiệu vào hệ thống HIS.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp thông báo nội dung Kết luận của Giám đốc đến các khoa, phòng liên quan để biết và nghiêm túc thực hiện.

GIÁM ĐỐC



BS. CKII. Trần Ngọc Hải